



ANALISIS ISU STRATEGIS DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS DATA HASIL KEGIATAN KELURAHAN CANTIK 2026

KELURAHAN BATARAGURU
KECAMATAN WOLIO · KOTA BAUBAU



Analisis Isu Strategis dan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Data Kelurahan Cinta Statistik Tahun 2026 – Kelurahan Bataraguru

Katalog : -
Nomor Publikasi : -
Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : ii + 8 halaman

Penyusun Naskah:

Mahasiswa Magang BPS Kota Baubau:

Dewi Maharani: D-III Statistika Universitas Halu Oleo

Penyunting:

Tim Pembina Desa Cantik BPS Kota Baubau:

L.M. Rizal, S.Tr.Stat. : Pembina Descan BPS Kota Baubau

Febiana Dahlia Anjani, S.Tr.Stat. : Pembina Descan BPS Kota Baubau

Sumber Ilustrasi:

Freepik.com, canva.com

Sumber Data:

- Hasil Pendataan Pokelcan 2026 Kelurahan Bataraguru
- Potensi Pembangunan Kelurahan Bataraguru 2026

5 ISU STRATEGIS DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berikut adalah hasil identifikasi terhadap 5 (lima) masalah utama yang ditemukan dari penelusuran data Pendataan Potensi Kelurahan Cinta Statistik (Pokelcan) 2026 Kelurahan Bataraguru, yang mencakup 30 RT pada 9 RW dengan total penduduk 6.283 jiwa (1.692 keluarga). Setiap masalah diuraikan berdasarkan topik, rincian data pendukung, latar belakang, dampak, serta solusi/rekomendasi kebijakan yang perlu ditempuh oleh pemerintah kelurahan.

1. **Pemerataan Akses Pendidikan dan Penguatan Layanan Pendidikan Dasar**

Topik masalah: Minimnya Sarana Pendidikan Formal di Hampir Seluruh RT dan Ketergantungan pada Satu Lembaga Swasta

Rincian data yang dipilih: Tabel 6.1 (Pos PAUD, TK, RA/BA), Tabel 6.2 (SD/MI), Tabel 6.3 (SMP/MTs), Tabel 6.4 (SMA/MA), Tabel 6.5 (SMK/PT)

Latar belakang: Dari 30 RT di Kelurahan Bataraguru, tidak ditemukan satu pun Pos PAUD Negeri maupun Swasta. Fasilitas pendidikan usia dini hanya berupa 1 unit TK Swasta (RT 04/RW 03) dan 1 unit RA/BA Swasta (RT 03/RW 05). Untuk jenjang dasar, hanya ada 1 unit SD Negeri di seluruh kelurahan (RT 01/RW 09), tanpa satu pun SD Swasta atau MI. Pada jenjang menengah, tidak ada satu pun SMP Negeri/Swasta; yang tersedia hanya 1 unit MTs Swasta, 1 unit MA Swasta, dan 1 unit Perguruan Tinggi Swasta, yang ketiganya berlokasi di RT yang sama yaitu RT 02/RW 03, dan tidak ada satu pun SMA maupun SMK (negeri atau swasta) di kelurahan ini. Artinya, dari 30 RT, hanya 4 RT yang memiliki fasilitas pendidikan formal apa pun, sementara 26 RT (sekitar 87 persen) sama sekali tidak memiliki sarana pendidikan, dan seluruh jenjang menengah-atas bergantung pada satu kompleks lembaga swasta saja. ketiadaan sarana pendidikan formal pada level RT perlu dilihat berimbang dengan aksesibilitas pada level kelurahan.

Tercatat meskipun SMP, SMA, SMK, MI, dan Perguruan Tinggi tidak tersedia di dalam kelurahan, jarak ke fasilitas terdekat tergolong dekat, yaitu SMP dan SMA sekitar 0,5 km, SMK sekitar 1,1 km, Perguruan Tinggi sekitar 1,2 km, serta MI sekitar 2,1 km, dengan tingkat kemudahan akses "sangat mudah" untuk seluruhnya. Dengan demikian, persoalan utama bukan semata ketiadaan akses fisik ke pendidikan menengah-atas, melainkan kesenjangan pemerataan sarana antar-RT 26 dari 30 RT tanpa fasilitas apa pun, serta beban biaya dan waktu transportasi bagi warga di RT yang jauh dari kompleks pendidikan di RT 02/RW 03. ini memperkuat arah solusi yang lebih diprioritaskan pada afirmasi/subsidi transportasi dan pemerataan PAUD berbasis RT, yang relatif lebih efisien secara anggaran dibandingkan pembangunan gedung sekolah baru.

Dampak dari masalah: Dalam jangka pendek, meskipun jarak ke fasilitas pendidikan menengah-atas di luar kelurahan relatif dekat (0,5–2,1 km dengan akses

"sangat mudah" menurut PODES 2025), anak usia dini di 26 RT tanpa Pos PAUD tetap kehilangan layanan yang seharusnya dekat dengan rumah, sementara keluarga kurang mampu di RT yang jauh dari kompleks pendidikan RT 02/RW 03 tetap menanggung beban biaya dan waktu transportasi harian, terutama jika ditempuh setiap hari selama bertahun-tahun. Ketiadaan opsi SMA/SMK negeri juga membatasi pilihan warga yang tidak mampu membiayai pendidikan swasta. Dalam jangka panjang, ketergantungan pada satu kompleks lembaga swasta menciptakan kerentanan sistemik: jika lembaga tersebut tutup atau bermasalah, seluruh kelurahan kehilangan akses pendidikan menengah tanpa alternatif di dalam wilayah sendiri. Kondisi ini juga berkontribusi pada rendahnya angka partisipasi PAUD dan menghambat peningkatan kualitas SDM kelurahan secara berkelanjutan.

Solusi/rekomendasi kebijakan untuk penyelesaian masalah: akses ke SMP, SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi terdekat sudah tergolong "sangat mudah" (0,5–2,1 km), prioritas kelurahan sebaiknya diarahkan pada solusi yang lebih efisien secara anggaran dibandingkan pembangunan gedung sekolah baru, yaitu: (1) mendorong berdirinya Pos PAUD berbasis RT/RW di seluruh 30 RT dengan memanfaatkan kader PKK, mengingat anak usia dini memerlukan layanan yang dekat dengan rumah; (2) mengusulkan program afirmasi/subsidi transportasi bagi siswa dari 26 RT yang jauh dari kompleks pendidikan RT 02/RW 03, khususnya untuk keluarga kurang mampu; dan (3) mendorong diversifikasi penyedia layanan pendidikan menengah swasta agar kelurahan tidak bergantung pada satu lembaga saja. Usulan pembangunan SD Negeri/Filial tambahan atau SMP Negeri kepada Dinas Pendidikan dapat dijadikan opsi jangka panjang, namun sebaiknya didahului kajian kebutuhan riil (jumlah anak usia sekolah per RT), mengingat akses ke fasilitas sejenis di luar kelurahan sudah relatif dekat.

2. Penguatan Cakupan Layanan Kesehatan Dasar dan Tenaga Kesehatan

Topik masalah: Rendahnya Cakupan Tenaga Kesehatan dan Posyandu Aktif di Tengah Ketergantungan pada Dukun Bayi

Rincian data yang dipilih: Tabel 7.4 (Posyandu Aktif, Posbindu, Kader), Tabel 7.5 (Dokter, Bidan, Nakes), Tabel 7.8 (Dukun bayi, stunting, gizi kurang)

Latar belakang: Posyandu aktif dengan kegiatan rutin bulanan dan Posbindu hanya ditemukan di 9 dari 30 RT (30 persen), dengan total 45 kader kesehatan se-kelurahan; sebanyak 21 RT (70 persen) sama sekali tidak memiliki Posyandu/Posbindu aktif. Pada saat yang sama, bidan yang tinggal/menetap hanya ditemukan di 4 dari 30 RT (RT 02/RW 02, RT 04/RW 03, RT 03/RW 05, dan RT 02/RW 09), sehingga 26 RT lain (87 persen) tidak memiliki bidan menetap di wilayahnya. Warga di 7 RT (RT 01/RW 02, RT 01/RW 05, RT 03/RW 05, RT 03/RW 07, RT 04/RW 07, RT 02/RW 08, RT 02/RW 09) masih mengandalkan dukun

bayi/dukun bersalin untuk persalinan; dari jumlah tersebut, 5 RT (RT 01/RW 02, RT 01/RW 05, RT 03/RW 07, RT 04/RW 07, RT 02/RW 08) sama sekali tidak memiliki bidan menetap di wilayahnya sendiri, sehingga warga benar-benar bergantung pada dukun bayi tanpa pendamping tenaga medis terlatih di dekatnya. Kasus gizi kurang juga tercatat di RT 01/RW 06, yaitu RT yang tidak memiliki Posyandu aktif.

Pertimbangan tambahan (Publikasi Potensi Pembangunan & Pokelcan): atas rendahnya cakupan Posyandu dan tenaga kesehatan di level RT. Pada level kelurahan, jarak ke rumah sakit terdekat sekitar 1,7 km, ke puskesmas rawat inap sekitar 2 km, ke poskesdes sekitar 2,3 km, ke praktik mandiri bidan sekitar 2,1 km, dan ke polindes sekitar 4,7 km, seluruhnya dengan kemudahan akses "sangat mudah"; kekecualian pada balai kesehatan yang berjarak sekitar 99,7 km dengan akses "sangat sulit", sebuah angka anomali yang perlu diverifikasi ulang validitasnya. Publikasi ini juga mencatat penurunan jumlah praktik mandiri dokter dari 5 menjadi 3 unit pada 2024-2025. Data Pokelcan 2026 pada level RT memberi gambaran lebih rinci: bidan menetap hanya ada di 4 RT, sehingga jarak "2,1 km, sangat mudah" pada data PODES sesungguhnya hanya representatif bagi RT yang berdekatan dengan salah satu dari 4 titik tersebut, sementara 26 RT lainnya perlu menempuh jarak yang kemungkinan lebih jauh. Artinya, meskipun fasilitas rujukan lanjutan (rumah sakit, puskesmas rawat inap) relatif terjangkau dari sisi jarak kelurahan, layanan promotif-preventif rutin dan tenaga bidan menetap justru timpang antar-RT. Kombinasi kedua data ini menegaskan bahwa solusi paling efisien bukan menempatkan bidan baru dari nol secara merata, melainkan meredistribusi cakupan layanan 4 bidan yang sudah ada melalui jadwal kunjungan/piket lintas-RT, sembari tetap mengaktifkan Posyandu di 21 RT yang belum memiliki layanan dan menambah bidan wilayah hanya untuk klaster RT yang benar-benar tidak terjangkau titik layanan mana pun.

Dampak dari masalah: Dalam jangka pendek, ibu hamil dan balita di 21 RT tanpa Posyandu aktif kehilangan akses rutin ke penimbangan, imunisasi, dan edukasi gizi. Minimnya bidan menetap (hanya 4 dari 30 RT) dan masih berlangsungnya praktik persalinan oleh dukun bayi di 5 RT yang sama sekali tidak memiliki bidan di dekatnya meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan yang tidak tertangani secara medis, membahayakan keselamatan ibu dan bayi. Dalam jangka panjang, rendahnya cakupan layanan kesehatan dasar berkontribusi pada risiko peningkatan kasus gizi kurang dan stunting, serta menurunkan kualitas kesehatan generasi mendatang.

Solusi/rekomendasi kebijakan untuk penyelesaian masalah: Kelurahan perlu berkoordinasi dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk mengaktifkan Posyandu di seluruh 21 RT yang belum memiliki layanan tersebut, termasuk merekrut dan melatih kader baru. Alih-alih menempatkan bidan baru secara merata dari nol, langkah yang lebih efisien adalah menyusun jadwal kunjungan/piket berkala bagi 4 bidan yang sudah menetap (RT 02/RW 02, RT 04/RW 03, RT 03/RW 05, RT 02/RW 09) agar dapat menjangkau RT terdekat yang belum memiliki bidan,

terutama 5 RT yang masih mengandalkan dukun bayi tanpa bidan di dekatnya (RT 01/RW 02, RT 01/RW 05, RT 03/RW 07, RT 04/RW 07, RT 02/RW 08). Penempatan bidan wilayah baru dapat difokuskan pada klaster RT yang benar-benar tidak terjangkau titik layanan mana pun. Program kemitraan bidan dengan dukun bayi tetap penting agar proses rujukan persalinan lebih aman, dan dapat dirintis lebih dulu di RT 03/RW 05 serta RT 02/RW 09 yang sudah memiliki bidan dan dukun bayi sekaligus sebagai percontohan model kemitraan. RT dengan kasus gizi kurang perlu diprioritaskan dalam program pemberian makanan tambahan (PMT) dan pemantauan gizi berkala.

3. **Penanganan Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni**

Topik masalah: Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni yang Terkonsentrasi Tanpa Bantuan Perumahan

Rincian data yang dipilih: Tabel 4.17 (Bantuan perumahan), Tabel 4.18 (Rumah tidak layak huni, sanitasi, air minum), Tabel 4.19 (Permukiman kumuh)

Latar belakang: Permukiman kumuh ditemukan di 3 dari 30 RT, yaitu RT 02/RW 08 (3 keluarga), RT 03/RW 08 (2 keluarga), dan RT 03/RW 09 (6 keluarga), dengan total 11 keluarga. RT 03/RW 09 merupakan wilayah paling rentan karena mengalami tumpang tindih masalah: rumah tidak layak huni dalam kategori "ada, sebagian besar", sanitasi buruk, dan sumber air minum tidak tersedia dalam kategori "sebagian besar", sekaligus menjadi salah satu lokasi permukiman kumuh. Rumah tidak layak huni kategori "ada, sebagian kecil" juga ditemukan di 6 RT lain (RT 02/RW 04, RT 01/RW 06, RT 02/RW 06, RT 02/RW 08, RT 03/RW 08, RT 01/RW 09). Sementara itu, tidak satu pun dari 30 RT yang pernah menerima program bantuan perumahan dalam setahun terakhir.

Secara agregat keluhan tidak terjadi kejadian pencemaran air, tanah, maupun udara, dan seluruh 2.615 keluarga telah teraliri listrik PLN. Namun temuan Pokelcan 2026 pada level RT menunjukkan adanya kantong-kantong permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni yang terkonsentrasi di RT 03/RW 09, RT 02/RW 08, dan RT 03/RW 08, lengkap dengan persoalan sanitasi dan akses air minum. Perbedaan tingkat kedalaman data ini menegaskan bahwa data agregat keluhan berpotensi menutupi kerentanan yang sebenarnya terlokalisasi di RT tertentu, sehingga pendataan dan intervensi berbasis RT menjadi krusial agar program Rutilahu dan perbaikan sanitasi tidak salah sasaran dan dapat dianggarkan secara lebih efisien dan tepat lokasi, alih-alih dialokasikan merata ke seluruh kelurahan.

Dampak dari masalah: Dalam jangka pendek, keluarga di RT 03/RW 09 menghadapi risiko kesehatan berlipis akibat kombinasi hunian tidak layak, sanitasi buruk, dan kesulitan akses air minum sekaligus. Dalam jangka panjang, tanpa intervensi, kondisi ini memperkuat siklus kemiskinan antar-generasi karena kualitas

hunian yang buruk berkorelasi dengan rendahnya derajat kesehatan dan produktivitas warga, sekaligus menghambat capaian target penurunan kawasan kumuh nasional.

Solusi/rekomendasi kebijakan untuk penyelesaian masalah: Kelurahan perlu menjadikan RT 03/RW 09 sebagai prioritas utama program Bedah Rumah/Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dari Kementerian PUPR atau APBD, mengingat tumpang tindih masalah perumahan, sanitasi, dan air minum di wilayah tersebut. Karena indikator agregat kelurahan pada Publikasi Potensi Pembangunan 2025 (pasokan listrik PLN 100 persen, tidak ada kejadian pencemaran) sudah tergolong baik, anggaran perbaikan sebaiknya difokuskan secara bertarget pada 3 RT yang teridentifikasi kumuh (RT 02/RW 08, RT 03/RW 08, RT 03/RW 09) dan 6 RT dengan rumah tidak layak huni sebagian kecil, bukan dialokasikan merata ke seluruh kelurahan. Kelurahan juga perlu mengusulkan pendataan by-name-by-address untuk 6 RT lain dengan rumah tidak layak huni, serta mendorong perbaikan akses air minum layak khusus di RT 03/RW 09 melalui program PDAM atau sumur bor komunal.

4. Penguatan Akses Air Bersih dan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Topik masalah: Ketidaklancaran Akses Air Ledeng dan Ketiadaan Bank Sampah di Seluruh Kelurahan

Rincian data yang dipilih: Tabel 4.9 (Bank sampah), Tabel 4.15 (Kelancaran akses ledeng meteran)

Latar belakang: Tidak satu pun dari 30 RT di Kelurahan Bataraguru memiliki bank sampah. Di sisi lain, RT yang sebagian besar keluarganya menggunakan ledeng meteran (PAM/PDAM) sebagai sumber air utama justru menghadapi kelancaran aliran yang sangat rendah: sebagian RT hanya mengalir 2 hari per minggu atau tiap 2 hari sekali, dan RT 01/RW 05, RT 02/RW 05, RT 03/RW 05, RT 01/RW 07, RT 02/RW 08, serta RT 03/RW 08 bahkan hanya mengalir 1 hari dalam seminggu. Tidak ada satu RT pun yang melaporkan aliran ledeng lancar setiap hari.

rincian pengelolaan lingkungan, tercatat "Tidak Ada Kegiatan" untuk pengolahan/daur ulang sampah (reduce, reuse, recycle) di seluruh kelurahan, sejalan dengan penggunaan pupuk organik, pembuatan lubang biopori, dan penampungan air hujan yang juga tercatat "Tidak Ada Kegiatan". mengenai RT dengan aliran ledeng hanya 1 hari per minggu tetap menjadi data primer yang perlu ditindaklanjuti langsung bersama PDAM. Kedua isu ini disarankan digabung dalam satu paket program lingkungan agar koordinasi lintas-RT dan penganggaran menjadi lebih efisien.

Dampak dari masalah: Dalam jangka pendek, keluarga di RT dengan ledeng hanya mengalir 1 hari per minggu harus menyediakan penampungan air cadangan atau membeli air isi ulang, menambah beban ekonomi rumah tangga, terutama pada

keluarga kurang mampu. Ketiadaan bank sampah di seluruh kelurahan berarti tidak ada mekanisme pengelolaan sampah berbasis nilai ekonomi (reduce-reuse-recycle), sehingga seluruh sampah rumah tangga berpotensi berakhir di TPA atau dibuang sembarangan. Dalam jangka panjang, kondisi ini meningkatkan volume sampah tak terkelola dan menghilangkan potensi ekonomi sirkular yang dapat menambah pendapatan warga.

Solusi/rekomendasi kebijakan untuk penyelesaian masalah: kelurahan disarankan menggabungkannya dalam satu paket Program Lingkungan Kelurahan agar koordinasi lintas-RT dan penganggaran lebih efisien. Paket tersebut mencakup: (1) koordinasi dengan PDAM untuk perbaikan jaringan distribusi air, dengan prioritas pada 6 RT yang aliran ledengnya hanya 1 hari per minggu (RT 01/RW 05, RT 02/RW 05, RT 03/RW 05, RT 01/RW 07, RT 02/RW 08, RT 03/RW 08); dan (2) pembentukan minimal satu bak sampah percontohan per RW (9 unit) dengan melibatkan kader lingkungan/PKK, disertai sosialisasi rutin mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah rumah tangga. sehingga edukasi lingkungan dapat disampaikan sekaligus dalam satu rangkaian kegiatan.

5. **Perbaikan Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial dan Sinkronisasi Data**

Topik masalah: Kesalahan Sasaran (Exclusion & Inclusion Error) dalam Penyaluran Bantuan Sosial Berbasis DTSEN

Rincian data yang dipilih: Tabel 3.4 (Kependudukan terkait DTSEN)

Latar belakang: Data DTSEN mencatat bahwa se-Kelurahan Bataraguru terdapat 88 keluarga yang mengalami perubahan desil sehingga kehilangan bantuan sosial yang sebelumnya diterima, 184 keluarga yang seharusnya menerima bantuan sosial namun tidak menerima (exclusion error), serta 9 keluarga yang seharusnya tidak berhak namun tetap menerima bantuan (inclusion error). Konsentrasi exclusion error tertinggi terjadi di RT 02/RW 09 (25 KK), disusul RT 01/RW 05 dan RT 04/RW 06 (masing-masing 15 KK), serta RT 03/RW 09 (15 KK). Kesalahan sasaran ini tersebar hampir merata di semua RW, menandakan masalah sistemik dalam pemutakhiran data, bukan sekadar kasus lokal di satu-dua RT saja.

Potensi Pembangunan Kelurahan Bataraguru Tahun 2025 mencatat lonjakan jumlah keluarga dari 1.473 (2024) menjadi 2.615 (2025), sementara Pokelcan 2026 mencatat cakupan populasi 1.692 keluarga untuk kelurahan yang sama. karena data kependudukan yang tidak konsisten antar-sistem berpotensi memperparah kesalahan sasaran (exclusion/inclusion error) pada penyaluran bansos berbasis DTSEN. Sinkronisasi data kependudukan lintas-sistem (PODES, Pokelcan, dan DTSEN) perlu menjadi bagian dari rekomendasi kebijakan, agar pemutakhiran desil kesejahteraan dilakukan di atas basis data yang seragam dan proses verifikasi lapangan dapat berjalan lebih efisien dari sisi anggaran maupun waktu.

Dampak dari masalah: Dalam jangka pendek, sebanyak 184 keluarga rentan kehilangan manfaat program bantuan sosial (bansos, subsidi, dan sejenisnya) yang seharusnya mereka terima, sementara program bantuan justru terserap oleh 9 keluarga yang sebenarnya tidak berhak. Dalam jangka panjang, kesalahan sasaran yang berulang dan tersebar luas ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem bantuan sosial pemerintah, memperlebar kesenjangan ekonomi antar-keluarga di tingkat RT, dan berpotensi menimbulkan gesekan sosial akibat rasa ketidakadilan dalam penyaluran bantuan.

Solusi/rekomendasi kebijakan untuk penyelesaian masalah: Kelurahan perlu melakukan verifikasi dan pemutakhiran data DTSEN secara berkala (minimal setiap semester) melalui musyawarah RT/RW, dengan prioritas pada RT 02/RW 09, RT 01/RW 05, RT 04/RW 06, dan RT 03/RW 09 yang memiliki jumlah exclusion error tertinggi. Kelurahan juga perlu membuka kanal pengaduan bagi warga yang merasa salah data, serta berkoordinasi aktif dengan Dinas Sosial untuk percepatan koreksi desil kesejahteraan bagi 88 keluarga yang mengalami penurunan desil. Mengingat ditemukan selisih signifikan antara jumlah keluarga hasil PODES 2025 (2.615 keluarga) dan Pokelcan 2026 (1.692 keluarga) untuk kelurahan yang sama, kelurahan juga perlu mengusulkan rekonsiliasi/sinkronisasi data kependudukan lintas-sistem (PODES, Pokelcan, dan DTSEN) kepada BPS dan Dinas Sosial, agar pemutakhiran desil kesejahteraan berpijak pada basis data yang seragam dan proses verifikasi lapangan berjalan lebih efisien dari sisi anggaran maupun waktu.



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

